

HEMATURIA

Diego Fernández-Samos Fernández, Mario de Arriba Alonso, Miguel Angel Alonso Prieto.

INTRODUCCIÓN

La hematuria (presencia de sangre en la orina) es uno de los principales motivos de consulta de origen urológico, pudiendo ser un signo de enfermedad potencialmente grave. Por lo tanto, es fundamental realizar un correcto diagnóstico diferencial y conocer las estrategias terapéuticas para su correcto manejo en el servicio de urgencias.

Se considera hematuria a partir de más de 2-3 hematíes por campo. A partir de 100 eritrocitos/campo hablamos de macrohematuria, mientras que por debajo de 100 eritrocitos/campo hablamos de microhematuria.

La hematuria se puede clasificar en función de su inicio durante la micción:

- **Hematuria inicial:** sospecha patología uretral, prostática o del cuello vesical.
- **Hematuria terminal:** sugiere origen vesical.
- **Hematuria total:** sugiere hemorragia supravesical (si es intensa puede ser originada en cualquier punto del tracto urinario).

La hematuria se puede clasificar según su aspecto.

- **Hematuria microscópica.** Se puede detectar usando tiras reactivas, llegando a tener una sensibilidad de aprox 90%. Se relaciona con enfermedad de vías superiores.
- **Hematuria macroscópica.** Se visualiza a simple vista, puede presentar o no coágulos. Generalmente esta hematuria se relaciona con enfermedad de vías inferiores, sin poder descartar otras causas como: patología vesical, ureteral o renal.

Entre las diversas **causas de hematuria** encontramos:

- Neoplasias malignas: vesicales, ureterales, renales, prostáticas y uretrales.
- Neoplasias benignas.
- Infecciosas. Pielonefritis, tuberculosis renal, esquistosomiasis, infección del tracto urinario.
- Litiasis urinaria.
- Hiperplasia benigna de próstata.
- Traumatismos urológicos.
- Nefropatías (glomerulares, tubulointersticiales, renovasculares).
- Fármacos (AINEs, rifampicina, ciclofosfamida, anticoagulantes) y radiación.
- Trastornos de la coagulación.
- Hematuria ex vacuo.
- Otras causas: ejercicio físico intenso, radiación, postparto, hipercalcemia.

DIAGNÓSTICO

Es fundamental realizar una buena anamnesis y exploración física en los pacientes que acuden con hematuria a urgencias, ya que las particularidades clínicas de cada paciente pueden orientarnos acerca de la causa y localización de la hematuria.

Anamnesis

- Factores de riesgo de cáncer urológico:
 - Edad mayor de 40 años.

- Hábito tabáquico y abuso de analgésicos.
- Irradiación pélvica y tratamiento con ciclofosfamida.
- Exposición a colorantes y compuestos de goma.
- Viaje reciente a zona endémica de esquistosomiasis.
- Presencia o ausencia de síntomas acompañantes.
- Presencia de coágulos.
- Momento de inicio de la hematuria (inicial, terminal o total).

Exploración Física

- Constantes vitales: temperatura, tensión arterial y frecuencia cardíaca.
- Exploración abdominal: permite descartar globo vesical, masas abdominales.
- Inspección de genitales externos.
- Tacto rectal en varones para evaluar la próstata.
- Puño-percusión renal.

Datos De Laboratorio

- Sistemático y sedimento de orina.
- Citología de orina.
- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, PCR.
- Coagulación.

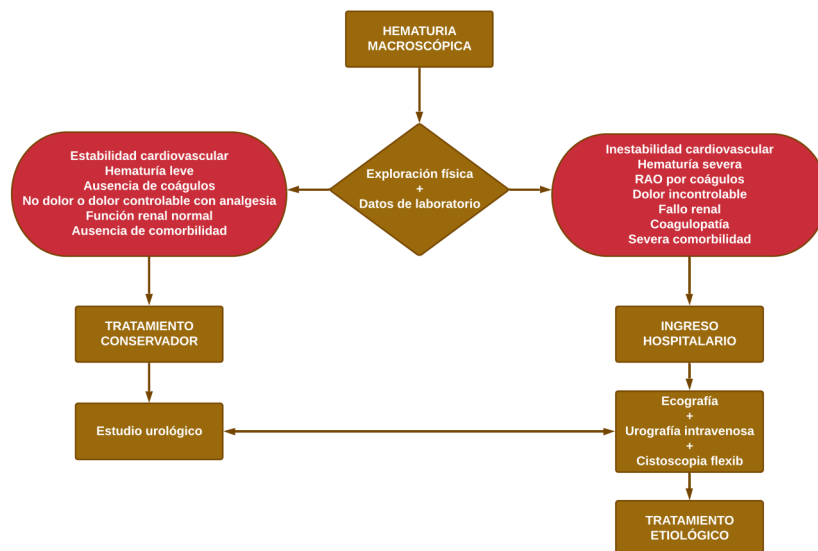
Pruebas De Imagen

- Radiografía de abdomen. Ayuda descartar cálculos radioopacos, tamaño y morfología renal.
- Radiografía de tórax posteroanterior y lateral. Si disnea o hemoptisis.
- Ecografía abdominal incluyendo sistema urológico. Información sobre litiasis, tumores, obstrucción...
- Urografía intravenosa: permite valorar la función y morfología renal bilateral, presencia de litiasis, dilatación de la vía urinaria y defectos de repleción.
- Cistoscopia: es la prueba de elección para valorar hematurias.
- Uro-TAC: en casos de persistencia de hematuria y exploraciones previas normales.

TRATAMIENTO

- TRATAMIENTO CONSERVADOR SIN SONDAJE VESICAL: reposo absoluto con control de constantes vitales. Indicado en casos de hematurias leves y autolimitadas, sin coágulos y sin signos de obstrucción urinaria.
- SONDAJE VESICAL: si la hematuria es intensa, con coágulos, se debe realizar un sondaje con sonda de Couvelaire de calibre 20-22 Ch para realizar lavados manuales con jeringa de cono ancho. Tras esta maniobra se coloca una sonda Foley de tres vías para realizar lavado vesical continuo hasta conseguir el aclaramiento de la orina.
- CRITERIOS DE INGRESO: inestabilidad hemodinámica, sepsis urinaria, dolor incontrolable, insuficiencia renal aguda, coagulopatía, RAO por coágulos, importante comorbilidad.
- TRATAMIENTO AMBULATORIO: si no existen criterios de ingreso, el paciente puede ser dado de alta con las siguientes recomendaciones:
 - Ingesta hídrica abundante (aproximadamente 3 litros al día).
 - Sonda permanente en casos seleccionados.
 - Antibioticoterapia: cefixima 1 comp/12 horas durante 6-12 días o ciprofloxacino 500 mg /12 horas durante 5-7 días.

- Cita preferente con el urólogo para estudiar el origen de la hematuria.



BIBLIOGRAFÍA

- Vázquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de Actuación en Urgencias, 3ª Edición. Ofelmaga 2008.
- Broseta E, Budía A, Burgués JP, Luján S, Jiménez Cruz JF. Hematuria macroscópica. ENE Ediciones. Urología Práctica 2011. Hospital Universitario y Politécnico La Fe Valencia: Aregraf; 2011: 28-30.
- Donate MJ, Salinas 1. AS, Virseda J. Hematuria. Capítulo del “Libro del Residente de Urología”. Asociación Española de Urología. Edit ENE. Madrid, 2007;111-119.
- Castiñeiras Fernández J, Carballido Rodríguez J, Franco de Castro A, Gausa Gascón L, Robles García J, Sánchez Chapado M, et al. Hematuria. ENE Ediciones. Libro del Residente de Urología. Madrid. 2007: 107-120.
- Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA. Evaluación del paciente urológico: anamnesis, examen físico y análisis de orina. Campbell-Walsh Urología. 9ª Edición. Madrid: Panamericana; 2008: 83.